1. Кожа развивается из следующих зародышевых листков:

1.экто- и мезодермы

2.мезодермы

3.энтеродермы

4.эктодермы

2. Масса кожи без гиподермы составляет:

1.**15%** от веса тела

2.**10%** от веса тела

3.-5% от веса тела

4.**20%** от веса тела

3. Площадь кожного покрова составляет:

*1.**1,5 – 2** кв. м*

2.**3,5 – 4** кв.м

3.**4,5 – 5** кв.м

4.**6 – 7,5** кв.м

4. За сутки с поверхности кожи испаряется:

*1.**600 – 800** мл водяных паров*

2.**50 – 100** мл водяных паров

3.**200 – 300** мл водяных паров

4.**1000 – 1500** мл водяных паров

5. Сальные железы выделяют за неделю:

*1.**100 – 200** гр. кожного сала*

2.**10 – 50** гр. кожного сала

3.**300 – 400** гр. кожного сала

4.**500 – 600** гр. кожного сала

6. В эпидермисе условно выделяют:

1.**3** слоя

2.**4** слоя

*3.**5** слоев*

7. В эпидермисе различают слои, кроме:

1.базального

2.шиповатого

3.зернистого

4.блестящего

5.рогового

6.сетчатого

8. В эпидермисе располагаются:

1.нервы

2.сосуды
3.эластические волокна
4.аргирофильные волокна
9.Клетки эпидермиса:
1.кератиноциты
2.меланоциты
3.тучные
4.Лангерганса
10. Делящимися клетками эпидермиса являются:
1.базальные
2.лимфоциты
3.макрофаги
4.тучные
11. Что входит в мальпигиев слой эпидермиса:
1.базальный
2.роговой
3.шиповидный
4.блестящий
12. Для клеток базального слоя характерно:
1.пигментообразование
2.митозы
3.кератинообразование
4.секреция кожного сала
13. Роговой слой эпидермиса:
1.соприкасается с внешней средой
2.является верхним слоем эпидермиса
3.состоит из безъядерных ороговевших клеток
4.на различных участках кожного покрова разной толщины
14. В дерме различают следующие слои:
1.базальный
2.сосочковый
3.сетчатый
4.зернистый
15. Клетками собственно кожи являются:
1.фибробласты
2.Гринштейна
3.меланоциты
4.гистиоциты
16. Лимфатические сосуды расположены в:

1.базальном слое эпидермиса
2.сосочковом и сетчатом слоях дермы
3.подкожной жировой клетчатке
4.блестящем слое эпидермиса
17. Кровеносные сосуды расположены в:
1.в базальном слое эпидермиса
2.в дерме
3.в шиповатом слое эпидермиса
4.в гиподерме
18. Сосуды кожи иннервируются:
1.только симпатической нервной системой
2.только парасимпатической нервной системой
3.симпатической и парасимпатической нервной системой
19. Дермографизм это:
1.ответная реакция сосудов кожи на механическое раздражение
2.ответная реакция нервов кожи на механическое раздражение
3.ответная реакция мышц кожи на механическое раздражение
20. Дермографизм в норме:
1.белый
2.красный
3.смешанный
4.отсутствует
21. Что воспринимают тельца Фатера – Пачини и Гольджи – Маццони:
1.чувство глубокого давления
2.чувство тепла
3.чувство холода
4.боль
22. Что воспринимают тельца Мейснера:
1.тактильную чувствительность
2.чувство холода
3.боль
4.не участвуют в восприятии
23. Что воспринимают тельца Руффини:
1.тепло
2.боль
3.чувство равновесия
4.чувство холода
24. Что воспринимают клубочки Краузе:
1.чувство холода

2.боль
3.чувство глубокого давления
4.чувство тепла
25. Придатками кожи являются:
1.волосы
2.сальные железы
3.потовые железы
4.ногти
26. Волосы бывают:
1.пушковые
2.щетинистые
3.длинные
4.короткие
27. Волос состоит из:
1.стержня
2.корня
3.мозгового слоя
4.коркового слоя
28. Длинные волосы локализуются на:
1.волосистой части головы
2.бороде и усах
3.надбровных дугах
4.ушных раковинах
29. Щетинистые волосы локализуются везде, кроме:
1.бороды и усов
2.области надбровных дуг
3.краев век
4.преддверия носа
30. Различают следующие типы потовых желез:
1.эккриновые
2.апокриновые
3.голокриновые
4.нормокриновые
31. Укажите разновидности сальных желез:
1.однодольчатые
2.двухдольчатые
3.пятидольчатые
32. Где локализуются сальные железы:
1.на лице

2.на волосистой части головы
3.на ладонях и подошвах
33. У кого апокриновые потовые железы не функционируют:
1.у мужчин
2.у женщин
3.у детей
4.у стариков
34. Основные функции кожи:
1.терморегулирующая
2.орган чувств
3.защитная
4.выделительная
35. Защитные свойства кожи от микроорганизмов осуществляются, благодаря:
1.потоотделению
2.слущиванию эпителия
3.кислой реакции
4.щелочной реакции
36. Первичными полостными элементами являются:
1.волдырь
2.пузырек
3.пустула
4.пузырь
37. Первичными бесполостными элементами являются:
1.папула
2.бугорок
3.волдырь
4.узел
38. К вторичным морфологическим элементам относятся:
1.чешуйки
2.рубец
3.узел
4.лихенизация
39. К вторичным морфологическим элементам не относятся:
1.пузырь
2.пустула
3.эрозия
4.вегетация

40. Какие первичные морфологические элементы исходят из эпидермиса:

1.эпидермальная папула

2.пузырек

3.пигментное пятно

4.пузырь

41. Какие первичные элементы заканчиваются язвами:

1.глубокая пустула

2.пузырек

3.узел

4.бугорок

42. Какие первичные элементы заканчиваются рубцами:

1.Узел

2.пузырек

3.бугорок

4.глубокая пустула

43. Какие первичные элементы заканчиваются образованием корок:

1.Пузырь

2.пятно

3.пустула

4.пузырек

44. Заболевания, которые проявляются мономорфными высыпаниями:

1.Псориаз

2.Экзема

3.пузырчатка

4.дерматит Дюринга

45. Заболевания, которые проявляются полиморфными высыпаниями:

1. болезнь Дюринга

2. вторичный сифилис

3. псориаз

4. экзема

46. Исход волдыря:

1. эрозия

2. язва

3. пятно
4. исчезает бесследно
5. корка

47. Язва представляет собой:

1.дефект кожи в пределах эпидермиса

2.глубокий дефект кожи

3.изменение цвета кожи

4.незначительное утолщение кожи

48. Везикула является первичным морфологическим элементом при:

1.крапивнице

2.экземе

3.опоясывающем лишае

4.нейродермите

49. Какие первичные морфологические элементы исходят из сосочкового слоя дермы:

1.волдырь

2.эпидермальная папула

3.пузырек

4.поверхностная пустула

50. Какие первичные морфологические элементы исходят из подкожной жировой клетчатки:

1.глубокие гнойнички

2.узлы

3.пузыри

4.бугорки

51. Полиморфные высыпания возникают при заболеваниях, кроме:

1.псориаза

2.красного плоского лишая

3.контагиозного моллюска

4.вторичного сифилиса

52. Воспалительные сосудистые пятна:

1.розеола

2.пурпура

3.телеангиэктазии

53. Невоспалительные сосудистые пятна:

1.розеолы

2.эритема

3.сосудистые невусы

54. По глубине залегания папулы бывают:

1.эпидермальные

2.эпидермо-дермальные

3.гиподермальные

4.дермальные

55. Фолликулярными пустулами являются ниже перечисленные, кроме:

1.остиофолликулита

2.фолликулита

3.фурункула

4.импетиго

56. После вскрытия пузырька образуется:

1.вегетация

2.язва

3.чешуйка

4.эрозия

57. Какие клинические проявления соответствуют картине истинного полиморфизма:

1.бугорок, язва, корка, рубец

2.пятно, папула, везикула
3.узел, язва, рубец
4.пятно, волдырь, пузырь
5.пузырек, эрозия, корка

58. Патогистологические изменения кожи связаны с:
1.нарушением процессов ороговения
2.воспалительными или экссудативными процессами
3.пролиферативными процессами

59. Гиперкератоз характерен для:
1.ихтиоза
2.рубромикоза
3.хронической красной волчанки
4.истинной экземы

60. Паракератоз характерен для:
1.псориаза
2.красного плоского лишая
3.простого пузырькового лишая
4.вторичного сифилиса

61. Акантолиз характерен для:
1.опоясывающего лишая
2.рубцующегося пемфигоида
3.дерматита Дюринга
4.акантолитической пузырчатки

62. Спонгиоз характерен для:
1.экземы
2.неаконтолитической пузырчатки
3.простого пузырькового лишая
4.туберкулеза кожи

63. Акантоз характерен для:
1.микробной экземы
2.псориаза
3.бородавчатого туберкулеза
4.себорейной пузырчатки

64. Гранулез характерен для:
1.псориаза
2.красного плоского лишая
3.истинной экземы
4.фурункулеза

65. Папилломатоз характерен для:
1.контагиозного моллюска
2.вульгарных бородавок
3.туберкулезной волчанки
4.зоонозной форма микроспории

66. Вакуольная дегенерация (внутриклеточный отек) характерна для:
1.псориаза волосистой части головы
2.экземы
3.аллергического дерматита
4.ихтиоза

67. Баллонирующая дегенерация характерна для:
1.простого герпеса
2.опоясывающего лишая
3.витилиго
4.онихомикоза

68. Примочки показаны при:
гиперкератозе
остром воспалении с мокнутьем
шелушении
зуде

69. В состав взбалтываемых смесей могут входить:
окись цинка
глицерин
вазелин
спирт

70. В мазевую основу не входят:
вазелин
спирт
вода
глицерин

71. В мазевую основу могут входить:
вазелин
древесный уголь
свиное сало
ланолин

72. Верна ли пропись**?**:
Rp.: Zinci oxydi 20,0 Talci 20,0 Glycerini 40,0 Vaselini 40,0 Aq. destillate ad 100,0 M.D.S. Взбалтываемая смесь
да
нет

73. Верна ли пропись**?**: **Rp.: Zinci oxydi 20,0 Talci 20,0 Glycerini 40,0 Vaselini**
40,0 Aq. destillate ad 100,0 M.D.S. Взбалтываемая смесь
да
нет

74. Верна ли пропись**?**: **Rp.: Sol. Thyamini bromidi 20 - 1,0 in amp. D.t.d. № 20.**
S. Для инъекций.
да
нет

75. Назовите противозудные средства:
окись цинка

ментол
анестезин
анилиновые краски

76. Дезинфицирующими средствами являются:
кортикостероиды
борная кислота
окись цинка
ментол

77. Кератолитическими средствами являются:
ихтиол
резорцин
тальк
салициловая кислота

78. Примочки оказывают следующее действие:
согревающее
противовоспалительное
дезинфицирующее
кератолитическое

79. Болтушки оказывают следующее действие:
подсушивающее
противозудное
противовоспалительное
кератопластическое

80. Лаки оказывают следующее действие:
кератолитческое
отслаивающее
противовоспалительное
противозудное

81. Стафилококки вызывают:
сикоз вульгарный
простой лишай
гидраденит
фурункул

82. Стрептококками вызываются:
простой лишай
импетиго
фолликулит
пузырчатка новорожденных

83. Волосяные фолликулы поражаются при:
импетиго
сикозе
фурункуле
псевдофурункулезе

84. При стафилодермиях поражаются:
гладкая кожа
слизистые
устья волосяных фолликулов
углы рта

85. При стрептодермиях поражаются:
гладкая кожа
волосяные фолликулы
сальные железы
потовые железы

86. При стафилодермиях поражаются:
гладкая кожа
слизистые
устья волосяных фолликулов
углы рта

87. Для лечения пиодермий применяют:
антибиотики
глюкокортикоидные гормоны
сульфаниламиды
вакцины

88. Для профилактики пиодермитов применяют:
дезинфекцию микротравм

УФО
витамины
общие ванны

89. Для лечения стафилококкового сикоза применяют:
биостимуляторы
глюкокортикоидные гормоны
антибиотики
мужские половые гормоны

90. Гидраденит вызывают:
стафилококки
стрептококки
синегнойная палочка
смешанная инфекция

91. В профилактике пиодермитов на производстве играет роль:
производственно-технические мероприятия
санитарно-гигиенические условия
лечебно-профилактические меры
санитарное просвещение

92. Вульгарный сикоз вызывается:
стафилакокками
стрептококками
вирусами

93. Вульгарнный сикоз чаще бывает у:
женщин
мужчин
детей

94. Вульгарный сикоз дифференцируют с:
красной волчанкой
псориазом
паразитарным сикозом
экземой

95. В лечении вульгарного сикоза применяются:

антибиотики
стероидные гормоны
иммунотерапия
цитостатики

96. Гидраденит бывает в:
подмышечной области
наружном слуховом проходе
ано-генитальной области
туловище

97. Гидроденит - это воспаление:
апокринных желез
сально-волосинных фолликулов
эккринных желез
молочных желез

98. Поверхностные стафилодермии:
остиофолликулит
фолликулит
фурункул
гидраденит

99. При глубоком фолликулите поражается:
устье фолликула
часть фолликула
весь фолликул
подкожная жировая клетчатка

100. Локализация фурункулов:
лицо
туловище
подошвы
ладони

101. При хроническом фурункулезе необходимо исключить:
сахарный диабет
ВИЧ-инфекцию
заболевания крови

инфекции, передающиеся половым путем

102. При остиофолликулитах применяют:
антибиотики внутрь
мази с антибиотиками
анилиновые краски
антимикотики

103. Для лечения карбункула применяются:
антибиотики внутрь
салициловая мазь
ихтиоловая мазь
оперативное вмешательство

104. Первичным морфологическим элементом при стрептококковом импетиго является:
пустула
фликтена (вялый пузырь)
волдырь
узел

105. Разновидности стрептококкового импетиго:
простой лишай
заеда
турниоль (околоногтевой импетиго)

106. В лечении стрептококкового импетиго применяют:
антибиотики внутрь
мази с антибиотиками
анилиновые краски
гормональные мази

107. Вульгарное импетиго вызывают:
стрептококки
стафилококки
смешанная инфекция
вирусы

108. Стрептодермией болеют чаще:

мужчины
женщины
дети

109. Какие из пиодермий требуют назначения антибиотиков внутрь:
карбункул
сикоз
фурункулез
остиофолликулит

110. Глубокие формы пиодермитов:
фурункул
карбункул
эктима
вульгарное импетиго

111. Контагиозным является:
стрептококковое импетиго
фурункулез
вульгарный сикоз
вульгарное импетиго

112. Основными показаниями для назначения антибиотиков при пиодермиях являются:
длительное хроническое течение заболевания
локализация глубоких пиодермий на лице
наличие регионарного лимфаденита
развитие анафилактического шока

113. Неспецифическая иммунотерапия больных фурункулезом включает:
аутогемотерапию
пирогенал
продигиозан
метилуарцил

114. Вирусами вызываются заболевания:
бородавки
герпес

красный плоский лишай
контагиозный моллюск

115. Какие вирусные болезни передаются половым путем:
генитальный герпес
опоясывающий лишай
остроконечные кондиломы
контагиозный моллюск

116. Какие морфологические элементы характерны для простого герпеса:
пузырьки, эрозии, корки
узелки, чешуйки
узелки, волдыри
гнойнички, язвы

117. Клинические проявления опоясывающего лишая:
ассиметрия поражений
безболезненность
пузырьки на фоне воспаленной кожи
отсутствие высыпаний

118. Для типичной формы опоясывающего лишая характерны:
эритема
отек
эрозии
некроз

119. Для опоясывающего лишая характерно:
сгруппированная сыпь
боли по ходу нервных стволов
общее недомогание
диффузная сыпь

120. Клинические разновидности опоясывающего лишая:
гангренозный
абортивный
генерализованный
язвенно-некротический

121. Простой пузырьковый лишай необходимо дифференцировать от:
афтозного стоматита
красного плоского лишая
опоясывающего лишая
твердого шанкра

122. Обычные бородавки необходимо дифференцировать от:
бородавчатого туберкулеза кожи
мозолей
бородавчатого акрокератоза Гопфа
себорейных бородавок

123. Остроконечные кондиломы небходимо дифференцировать от:
широких кондилом
вегетирующей пузырчатки
вегетирующей пиодермии
эпителиомы

124. При заразительном моллюске первичным элементом является:
папула
бугорок
пузырек
волдырь

125. Пути заражения остроконечными кондиломами:
половой
трансфузионный
тесный бытовой контакт
воздушно-капельный

126. Противовирусным эффектом обладают мази:
серная
оксолиновая
завиракс
декаминовая

127. Для лечения бородавок используют:
кератолитические препараты

противовирусные средства
хирургические методы
ПУВА-терапию

128. При контагиозном моллюске у ребенка следует провести следующие мероприятия:
изоляция от здоровых детей
гормональная терапия
УЗИ внутренних органов
антибиотиотерапия

129. Возбудитель чесотки:
вирус
простейшие
паразиты
бактерии

130. В каком слое кожи самка клеща прокладывает чесоточный ход:
в блестящем
в зернистом
в роговом
в шиповатом

131. Наиболее частая длительность инкубационного периода при чесотке:
5-12 дней
21 день
6 недель
4 мес

132. Пути заражения чесоткой:
половой
воздушно-капельный
через общую постель
при поцелуе

133. Основными симптомами чесотки являются:
парные папуло-везикулярные элементы
интенсивный зуд в вечернее и ночное время суток

наличие чесоточных ходов
характерная локализация высыпаний

134. При чесотке чаще поражаются:
межпальцевые промежутки
живот
лицо
половые органы

135. Для клиники чесотки характерны следующие морфологические элементы:
лентикулярные папулы
бугорки
парные зудящие узелки и пузырьки
узлы

136. Симптомы Горчакова-Арди, Михаэлиса, Сезари выявляются при:
чесотке
педикулезе
лейшманиозе
вульгарных угрях

137. Симптом Горчакова-Арди – это:
гнойные и кровянистые корочки в области локтевых суставов
кровянистые корочки в межягодичной складке
зуд, усиливающийся в вечернее время суток
экскориации вследствие расчесов

138. Клинические разновидности чесотки:
типичная
детская
чесотка без ходов
норвежская
«чистоплотных» или «инкогнито»
осложненная
скабиозная лимфоплазия кожи
псевдочесотка или псевдосаркоптоз

139. Укажите наиболее частые осложнения чесотки:

сепсис
вторичная пиодермия
экзема
дерматит

140. Диагностика чесотки должна основывается на:
жалобах пациента
эпиданамнезе
клинической картине
лабораторной диагностике

141. На основании какого метода лабораторной диагностики устанавливается окончательный диагноз «чесотка»:
посев на питательную среду
РИФ
ПЦР
микроскопия

142. Для постановки окончательного диагноза чесотки главным критерием является:
зуд
наличие расчесов
обнаружение чесоточного клеща
наличие пузырьков

143. Для лечения чесотки применяют:
спрегаль
бензил-бензоат
перметрин
любую гормональную мазь

144. Противоэпидемиологические мероприятия при чесотке:
душ до и после лечения
дезинфекция белья
вакцинация
профлечение контактных лиц

145. Назовите основные разновидности вшей, поражающих человека:
половные

платяные
бытовые
половые

146. Какие лекарственные средства используются для лечения педикулеза:
флуцинар
нео-пенотран
ниттифор
аугментин

147. Осложнения головного педикулеза:
пиодермия
алопеция
аллергические реакции
повышение температуры

148. Лобковым педикулезом можно заразиться:
в бане
при половых сношениях
при посещении бассейна
на пляже

149. Классификация дерматомикозов по МКБ – **10**:
микоз волосистой части головы
микоз гладкой кожи
микоз крупных складок
микоз кистей и стоп
микоз ногтей (онихомикоз)

150. Заболевания, относящиеся к трихомикозам:
трихофития
руброфития
микроспория
эпидермофития
фавус

151. Виды микроспории:
антропофильная (антропонозная)

зоофильная (зоонозная)
геофильная

152. Клинические формы зоонозной микроспории:
волосистой части головы
гладкой кожи

153. Источник заражения зоонозной микроспорией:
грызуны
кошки, собаки
коровы, лошади
птицы

154. Источник заражения хронической трихофитией:
кошки
люди
птицы
телята

155. Поверхностной трихофитией болеют:
доярки
дети
взрослые мужчины
работники ферм

156. Возбудителем рубромикоза является:
Trichophyton rubrum
Epidermophyton floccosum
Corynebacteria minutissima
Pityrosporum orbiculare

157. Возбудителем антропонозной микроспории является:
Microsporum ferrugineum
Microsporum lanosum
Trichophyton schonleinii
Trichophyton violaceum

158. Возбудителем антропофильной трихофитии является:
Trichophyton violaceum

Trichophyton rubrum
Pitysporum orbiculare
Trichophyton verrucosum
Microsporum ferrugenii

159. Возбудителем паразитарного сикоза является:
Trichophyton rubrum
Trichophyton Schoenleini
Trichophyton gypseum
Trichophyton violaceum

160. Люминесцентное свечение при обследовании с помощью лампы Вуда обнаруживается у больных с:
зоонозной микроспорией
поверхностной трихофитией
фавусом
инфильтративно-нагноительной трихофитией

161. Диагноз зоонозной микроспории волосистой части головы можно подтвердить с помощью:
микроскопии
пробы Бальцера
люминесцентного свечения
культуральной диагностики

162. На высоте **5- 8** мм над уровнем кожи волосы обламываются при:
трихофитии
микроспории
фавусе
гнездной алопеции

163. Для микроспории гладкой кожи не характерно:
наличие эритемато-сквамозных очагов
нечеткие границы и быстрое саморазрешение
шелушение
пузырьки по краю очага

164. Для диагностики грибковых заболеваний применяют следующие исследования:

серологические
микроскопические
иммунологические
бактериологические

165. Дифференциальная диагностика микроспории проводится с:
трихофитией
фавусом
себорейной экземой
розовым лишаем
рубромикозом

166. Для хронической трихофитии характерно:
обламыванием волос на уровне кожи — симптом "черных точек"
кораллово-красное свечение при обследовании с помощью лампы Вуда
на гладкой коже очаги не имеют резких границ, застойно-синюшного цвета
споры гриба внутри волос расположены по типу эндотрикс

167. При фавусе поражаются:
волосистая часть головы
ногти
гладкая кожа
внутренние органы

168. Для фавуса нехарактерно:
наличие корок
ломкость волос и образование папул
рубцы
атрофия волос

169. Клиника фавуса проявляется:
обламыванием волос
облысением
атрофией

170. Для скутулярной формы фавуса характерно:
атрофичность и безжизненность волос

мышиный запах
зуд
рубцовая атрофия

171. Клинические формы эпидермофитии стоп:
сквамозная
дисгидротическая
отрубевидная
ногтей

172. Для паховой эпидермофитии не характерны:
инфильтрация
кирпично–красная окраска
корралово-красное свечение при люменисценции
папулезные высыпания

173. Клиника паховой эпидермофитии:
отечно-гиперемированное пятно
поражение ногтевых пластинок
воспалительный венчик по периферии очагов
зуд

174. Для глубокой трихофитии характерно:
общее недомогание с повышением температуры тела
наличие островоспалительного инфильтрата
самопроизвольное разрешение
симптом « медовых сот»

175. Для рубромикоза характерен:
акантоз
гиперкератоз
спонгиоз
паракератоз

176. Для лечения рубромикоза применяются:
местные и системные антимикотики
витамины
цитостатики
глюкокортикоиды

177. При рубромикозе поражаются:
ногтевые пластинки
пушковые волосы
ладони и подошвы
гладкая кожа

178. Ногтевые пластинки поражаются при:
псориазе
кандидозе
красном плоском лишае
рубромикозе

179. Для онихомикоза характерно:
деформация и утолщение ногтей
напертсковидная дистрофия
крошащийся и изъеденный со свободного края ноготь
тусклая, желтовато – серая окраска ногтей

180. Комплексное лечения микроспории включает:
гризеофульвин
наружные средства
витамины
антигистаминные препараты

181. Для общего лечения трихомикозов применяют:
нистатин
орунгал
ламизил
леворин

182. Для наружного лечения эпидермофитии применяют:
примочки в случае мокнутия
гормональные мази
противогрибковые мази
мази с нафталаном

183. Для наружного лечения микозов не применяются:
микосептин

ламизил
клотримазол
преднизолон

184. К псевдомикозам относятся:
Трихофития
эритразма
актиномикоз
кандидоз

185. Эритразма локализуется в:
паховой области
подмышечных впадинах
стопах
ягодицах

186. Лечение эритразмы проводится:
эритромициновой мазью
оксолиновой мазью
анатоксином
оксикортом

187. Проба Бальцера положительная при:
кандидозе
эпидермофитии стоп
разноцветном лишае
рубромикозе

188. Кандидоз кожи и слизистых вызывает:
Trichophyton rubrum
Candida albicans
Epidermophyton floccosum
Corynebacteria minutissima
Pityrosporum orbiculare

189. Кандидоз кожи проявляется:
эрозиями
белым налетом
выраженным шелушением

мокнутием

190. При кандидозе поражаются:
волосистая часть головы
гладкая кожа
слизистые
ногтевые пластинки

191. Возбудителем отрубевидного лишая является:
Pityrosporum orbiculare
Corynebacterium minutissimum
Epidermophyton floccosum
Trichophyton mentagraphytes var interdigitale

192. Лечение отрубевидного лишая:
аэрозоль «Ламизил»
гидрокортизон
салициловый спирт
общее УФО

193. Основной тип аллергических реакций при васкулитах кожи:
анафилактоидные
цитотоксические
иммунокомплексные
анафилактоидные и цитотоксические

194. Васкулиты делятся:
на поверхностные и глубокие
на инфекционные и неинфекционные
на инфекционные и лекарственные
вроженные и приобретенные

195. При геморрагическом васкулите кроме кожи, поражаются:
нервная система
сосуды внутренних органов
суставные хрящи
эндокринная система

196. В патогенезе васкулитов играет роль:

наследственность
фокальная инфекция
пищевые аллергены
аутоиммунные процессы

197. Для аллергических васкулитов характерны:
острое начало
наличие геморрагического компонента в высыпаниях
полиморфизм высыпаний
кашель

198. Узловатая эритема проявляется:
узлами на коже туловища
узлами на коже голеней, бедер
повышением температуры
сезонностью

199. Для лечения васкулитов применяются:
антибиотики
гипосенсибилизирующие, антигистаминные средства
кортикостероиды
иммуномодуляторы

200. Профилактика аллергических васкулитов:
лечение фокальной инфекции
исключение переохлаждения
рациональное питание
лечение ревматизма

201. Укажите облигатные предраковые болезни:
болезнь Боуэна
пигментная ксеродерма
лейкоплакия
эритроплазия Кейра

202. Укажите факультативные предраковые болезни:
акнический хейлит
болезнь Педжета
трофическая язва

хроническая трещина нижней губы

203. Укажите злокачественные опухоли:
базалиома
кератоакантома
меланома
ботриогранулема

204. Для лечения лимфом применяют:
кортикостероиды
цитостатики
лучевую терапию
препараты цинка

205. Эритроплазию Кейра дифференцируют с:
кандидозным баланопоститом
твердым шанкром
герпесом
мягким шанкром

206. Базалиома чаще локализуется на:
ладонях
лице
туловище
бедрах

207. Базально-клеточную эпителиому дифференцируют с:
спиноцеллюлярным раком
экземой
хронической красной волчанкой
псориазом

208. При хронической красной волчанке поражаются:
почки
печень
ц.н.с
кожа

209. Симптомы хронической красной волчанки:
гиперкератоз
эритема
атрофия
мокнутие

210. Типичная локализация хронической волчанки:
лицо
ладони
ушные раковины
волосистая часть головы

211. Для диссеминированной формы красной волчанки характерны:
распространенный характер сыпи
небольшие очаги поражения
лихенизация
поражения закрытых участков кожи

212. Для центробежной эритемы характерны:
эритема
фолликулярный гиперкератоз
атрофия

213. Для лечения хронической красной волчанки применяют:
УФО
препараты резохинового ряда
кортикостероиды
антибиотики

214. В системную красную волчанку чаще переходит:
дискоидная красная волчанка
центорбежная эритема Биетта
диссеминированная красная волчанка

215. В настоящее время красную волчанку относят к:
инфекционным заболеваниям
аутоиммунным заболеваниям
вирусным заболеваниям
венерическим болезням

216. О переходе хронической красной волчанки в системную говорит:
LE- феномен
ускорение СОЭ
альбуминурия
лейкопения

217. Диагностические симптомы дискоидной красной волчанки:
симптом Никольского
симптом Бенье-Мещерского
симптом “дамского каблучка”
симптом “ кровяной росы”

218. Излюбленная локализация дискоидной красной волчанки:
туловище
лицо
ушные раковины
волосистая часть головы

219. Дифференционный диагноз дискоидной красной волчанки проводят с:
псориазом
туберкулезной волчанкой
простым контактным дерматитом
красным плоским лишаем

220. Очертания бабочки характерны для:
дискоидной красной волчанки
ценробежной эритемы Биетта
диссеминированной красной волчанки
витилиго

221. Для местного лечения красной волчанки применяются
мази с антибиотиками
стероидные мази
салициловая мазь
противогрибковые мази

222. Дискоидная красная волчанка заканчивается:

рубцеванием
пигментным пятном
проходит бесследно
трансформируется в лимфому

223. Для склеродермии характерны стадии:
отека
атрофии
шелушения
уплотнения

224. Для лечения склеродермии применяют:
УФО
антибиотики
лидазу
кортикостероиды

225. Для лечения очаговой склеродермии применяют:
примочки
УФО
парафин
ПУВА - терапию

226. Бляшечная склеродермия заканчивается:
рубцевой атрофией
пигментным пятном
проходит бесследно
присоединением вторичной инфекции

227. Первичные морфологические элементы при туберкулезной волчанке:
бугорки
язвы
узлы
папулы

228. Назовите локализованные формы туберкулеза кожи:
лихеноидный
бородавчатый

индуративный
колликвативный

229. Для туберкулезной волчанки характерны:
симптом Поспелова
симптом «стеаринового пятна»
симптом «яблочного желе»
симптом Бенье-Мещерского

230. Папуло-некротический туберкулез локализуется на:
лице
волосистой части головы
голенях
подошвах

231. Папуло - некротический туберкулез дифференцируют от:
многоформной экссудативной эритемы
почесухи
псориаза
скрофулодермы

232. Туберкулезную волчанку дифференцируют от:
дискоидной красной волчанки
бугоркового сифилида
лепры
индуративной эритемы Базена

233. Скрофулодерма чаще локализуется:
область шеи
паховая область
бедра
туловище

234.Скрофулодерму необходимо дифференцировать от:
.
-гуммозного сифилида
лейшманиоза
лепры
простого герпеса

235. Бородавчатый туберкулез чаще локализуется на:
туловище
тыле кистей
волосистой части головы
ладонях

236. Для туберкулезной волчанки характерны:
эпителиоидные клетки
гигантские клетки (Лангханса)
лимфоциты
плазматические клетки

237. Индуративную эритему Базена дифференцируют с:
геморрагическим васкулитом
узловатой эритемой
лепрой
третичным сифилисом

238. Микобактерии туберкулеза попадают в кожу:
гематогенным путем
лимфогенным путем
воздушно-капельным путем
трансплацентарно

239. Диагноз туберкулеза кожи ставят на основании:
туберкулиновых проб
биопсии кожи
флюорографии легких
всех выше перечисленных методов

240. Туберкулез кожи лечат:
пенициллином
тетрациклином
рифампицином
герпевиром

241. Узловатая эритема Базена локализуется на:
лице

туловище
голенях
волосистой части головы

242. Рубцы после туберкулезной волчанки:
мозаичные
звездчатые
по типу “смятой папиросной бумаги”

243. Рубцы после скрофулодермы:
звездчатые
мозаичные
мостовидные

244. Язвенный туберкулез кожи локализуется на:
бедрах
туловище
у естественных отверстий

245. При бородавчатом туберкулезе микобактерия попадает в кожу:
гематогенным путем
лимфогенным путем
через поврежденную кожу

246. Бородавчатый туберкулез кожи дифиринцирует с:
хронической пиодермией
аллергическим дерматитом
псориазом

247. Лихеноидный туберкулез относится к:
локализованным формам
диссеменированным формам

248. Для городского типа лейшманиоза характерно:
длительный инкубационный период
хроническое течение
сезонность заболевания
короткий инкубационный период

249. Источником заражения сельским типом лейшманиоза являются:
больные кошки
грызуны
крупный рогатый скот
больные люди

250. Для кожного лейшманиоза характерны стадии:
пятна
бугорков
уплотнения
рубцевания

251. Методы лабораторной диагностики лейшманиоза:
микроскопия
посев на питательную среду
гистологический
проба с аллергеном

252. Меры профилактики лейшманиоза:
вакцинация
борьба с грызунами
применение репеллентов
противомоскитные сетки

253. Источники заражения городским типом являются:
грызуны
крупный рогатый скот
больные люди
кошки, собаки

254. Переносчиками лейшманий являются:
москиты
больные животные
больные люди
грызуны

255. Для клиники лейшманиоза характерны:
бугорок
язва
рубец
все выше названные

256. В лечении лейшманиоза используют:
гормоны
антибиотики
сульфаниламидные препараты
противогрибковые препараты

257. Клинические формы лепры:
лепроматозная
индуративная
недифференцированная
туберкулоидная

258. Пути заражения лепрой:
половой
воздушно-капельный
через кровососущих насекомых
через поврежденную кожу

259. Возбудитель лепры:
простейшие
микобактерии
спирохеты
вирусы

260. Субъективные расстройства при лепре:
парастезии
нарушение температурной чувствительности
нарушение болевой чувствительности
нарушение тактильной чувствительности

261. Для лечения лепры могут применяться:
сульфоновые препараты
антибиотики

иммуномодуляторы
гормоны

262. Инкубационный период при лепре:
несколько дней
несколько месяцев
несколько лет
несколько часов

263. Микобактерии лепры ищут:
в мократе
в кале
в соскобе со слизистой носа
в моче

264. Клинические тесты при лепре:
проба с гистамином
иодно - крахмальная проба (Минора)
проба Ядассона
проба Бальцера

265. При лепроматозном типе лепры:
узлы
бугорки
папулы
пятна

266. При туберкулоидном типе лепры:
пятна
папулы
узлы
волдыри

267. Проба с лепромином при лепроматозном типе:
положительная
отрицательная

268. У здоровых людей проба с лепромином:
положительная

отрицательная

269. Нарушение чувствительности наступает раньше при:
туберкулоидном типе лепры
лепроматозном типе лепры
недифиринцированном типе лепры

270. Лепроматозный тип лепры дифференцирует с:
псориазом
красным плоским лишаем
гуммозным сифилидом
розовым лишаем

271. Туберкулоидный тип лепры дифференцируют с:
витилиго
красным плоским лишаем
бугорковым сифилидом
бляшечной склеродермией

272. Мутиляция пальцев бывает при:
лепроматозном типе лепры
туберкулоидном типе лепры
недифферинцированном типе лепры

273. Простой контактный дерматит может возникнуть на воздействие:
кислот, щелочей
высокой температуры
косметических средств
стиральных порошков

274. Аллергический дерматит возникает при воздействии:
стиральных порошков
косметических средств
концентрированных кислот и щелочей
высоких и низких температур

275. Проявление простого контактного дерматита:
эритема
пузыри

папулы
волдыри

276. Проявление аллергического дерматита:
эритема
пузыри
папулы
гнойнички

277. Простой контактный дерматит возникает через:
несколько минут
несколько дней

278. Аллергический дерматит возникает через:
несколько минут
несколько часов
несколько дней

279. Аллергический дерматит возникает при воздействии аллергена:
на кожу
прием внутрь

280. Для лечения аллергического дерматита используют:
антигистаминные препараты
антибиотики
стероидные гормоны
противогрибковые препараты

281. Токсикодермии вызывают:
медикаменты
продукты питания
укусы насекомых

282. Для токсикодермии характерны:
пузыри
волдыри
бугорки
узлы

283. В лечении токсикодермии применяют:
антигистаминные препараты
гипосенсибилизирующие препараты
стероидные гормоны

284. Тяжелой формой токсикодермии является:
сидром Лайелла
синдром Стивенсан-Джонсона

285. Для синдрома Лайелла характерны:
пузыри
эрозии
волдыри

286. При синдроме Лайелла симптом Никольского:
отрицацельный
положительный

287. Первичные элементы при истинной экземе:
бугорки
пятна
папулы
везикулы

288. В основе экземы лежат патогистологические изменения:
паракератоз
спонгиоз
акантолизис
вегетация

289. Себорейная экзема локализуется на коже:
спины
лица
нижних конечностей
волосистой части головы

290.Для истинной экземы характерны:
симметричность очагов
асимметричность

четкие границы
«архипелаг островов»

291. Для микробной экземы характерны:
асимметричность очагов
четкие границы
симметричность очагов

292. Частая локализация микробной экземы:
лицо
туловище
нижние конечности

293. В лечении экземы используют:
антигистаминные препараты
десенсибилирующие препараты
витамины

294. Факторы, способствующие развитию профессиональных болезней кожи:
смолы
растворители
спирт
известь

295. Разновидности профдерматозов, вызываемых производственными аллергенами:
профессиональная экзема
профессиональная токсикодермия
профессиональная крапивница
розовый лишай

296. Профдерматозы, вызываемые инфекционными и паразитарными агентами:
эризепелоид
глубокая трихофития
красный плоский лишай
-кандидозы

297. Производственными аллергенами могут быть:
синтетический клей
антибиотики
краски
эпоксидные смолы

298. Для профессионального дерматоза характерно:
локализация поражений на открытых участках кожи
положительные результаты кожных аллергических проб
подобные поражения кожи у других, работающих на данном технологическом процессе
выздоровление во время отпуска

299. Для подтверждения диагноза профдерматоза необходима документация:
выписка из амбулаторной карты
санитарно-гигиеническая характеристика рабочего места
служебная характеристика больного
выписка из трудовой книжки

300. Меры профилактики профдерматозов:
автоматизация производства
спецодежда
вентиляция
чистота рабочего места